六、 居家心脏超声治疗：做什么、为什么合规

设备	心脏超声波治疗仪（SUT-C），注册证法定适用范围：冠心病的辅助治疗。
应用	按医嘱居家使用，每日 1 次、每次 30 分钟；属物理治疗，非药物、非手术。
机理	高频机械振荡与空化效应扩张血管、改善血液循环；理化与温热效应促进侧枝循环、改善微循环。

七、 五个运动康复计划（按恢复状态选择）

A 呼吸与放松



A01 腹式呼吸（坐）



A03 坐位耸肩

B 步行进阶



B02 扶门慢走（站）



B03 户外快走

D 传统功法



D02 太极云手

医生按患者恢复状态，从 A/B/C/D/E 中选定一个计划；每个计划含多组动作，居家按视频执行。

八、 权威依据

《中国心脏康复与二级预防指南 2018》——心脏康复五大处方：药物、运动、营养、心理（含睡眠）、戒烟。

《慢性心力衰竭心脏康复中国专家共识》《PCI 术后运动康复专家共识》——奠定运动康复的临床地位。

《冠心病患者运动治疗中国专家共识》《心脏康复分级诊疗中国专家共识》——支撑院内—居家分级延续。

智慧居家康复的完整形态

院内—居家一体化的心脏健康管理闭环 · 圆爱康

心脏健康管理闭环

让心内科每一位患者都被管起来

从评估、手术到术后居家康复——
一条让心内科患者「进得来、管得住、跟得上」的完整管理链路

① 进来
患者进入心内科门诊 / 住院

② 评估
心功能分级 / 冠脉评估 / 危险因素

③ 分岔
一次评估，分出两条路

④ 无手术指征
进入居家心脏康复
减轻症状、控制风险

⑤ 有手术指征
院内安排手术 / 介入
术后转入居家心脏康复

⑥ 管起来 —— 一条闭环
院内段由 CMS 患者管理系统管，出院后由居家康复系统接着管
两段接上，就是一条闭环

圆爱康帮心内科，把全部患者（而不只是术后患者）
纳入心脏健康管理闭环。

一、 患者进来之后，是怎么被管起来的

建档入组

患者进入心内科门诊 / 住院，由科室医生完成评估（心功能分级、冠脉情况、危险因素）

一次评估，分出两条路：

无手术指征	有手术指征
进入居家心脏康复， 减轻症状、控制风险； 持续康复管理，防止病情进展	院内安排手术 / 介入治疗； 术后转入居家心脏康复， 巩固疗效、预防再发

→ 心内科每一位患者都被纳入管理，不再有「看完门诊就断了」的患者。

二、 院内段：CMS 患者管理系统

CMS 患者管理系统 —— 我们把科室里的患者管起来：

端口	使用者	管理内容
医护 PC 管理端	科室医护	患者档案、治疗方案录入下发、治疗数据查看、依从性监测、复诊提醒、治疗量统计
医生管理小程序	科室医生	随时查看患者数据、调整方案、接收消息提醒
患者使用小程序	患者	预约登记、治疗记录查看、就诊提醒、健康信息填报

可单独部署，也可与居家系统组合；可按模块拆用，科室按需选用。

CMS 覆盖四类管理场景：专科管理 / 居家衔接 / 运营统计 / 筛查与活动入组

三、 六师共管 · 全程有人管

患者从院内到居家，全程不是一个医生在扛，而是一个团队：

四、 出院回家之后，康复接着走

患者出院回家后，康复由智慧居家康复系统承接：

医生端

- 查看康复方案与执行回执
- 训练时长与完成度可追踪
- 可远程调整方案

患者端

- 视频动作指导，大字幕
- 心脏超声治疗仪按医嘱居家使用
- 每日训练任务清晰可执行

两段怎么接上

院内段 → CMS 管理：患者、治疗路径、依从性、复诊，全在 CMS 里
出院 → 转入居家康复系统：治疗方案在院外延续
合起来 = 院内—居家完整闭环，即智慧居家康复的完整形态

患者是怎么被管着的（一条管理过程）：

建档入组 → 医生核定方案并下发 → 患者居家执行（系统按日推送任务）→ 执行情况被跟踪，未坚持的有人提醒 → 按疗程生成报告供医生查阅 → 医生按数据远程调整方案 → 复诊衔接

五、 居家康复套餐：三档

患者出院转入居家康复，按需选择一档：

套餐	超声治疗	运动康复	适合谁
套餐一	20 次	5 个计划选 1	先做一段看效果
套餐二	40 次	5 个计划选 1	需要持续治疗一段时间
套餐三	60 次	5 个计划选 1	周期较长、希望长期坚持

三档都含：居家超声治疗 + 运动康复 + 六师共管
院内配套（科室按自身条件组合）：六分钟步行试验、心脏彩超、Holter、CPET、体外反搏、营养体重管理处方、综合评估（心理/睡眠/躯体化/前列腺/便秘等）

怎么选：以医生评估意见为准。